

MINISTERE DE LA SANTE

*_*_*_*_*_*_*_*

SECRETARIAT GENERAL

*_*_*_*_*_*_*_*

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DE OUAGADOUGOU

*_*_*_*_*_*_*_*

LICENCE EN SOINS INFIRMIERS-OBSTETRICAUX

PROMOTION 2022-2025

BURKINA FASO

*_*_*_*_*_*_*

Unité-Progrès-Justice



RAPPORT DE STAGE DE MILIEU RURAL

EFFECTUE AU CM DE NIOU

ETUDE DE FAMILLE

PERIODE DE STAGE DU 01 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2025

Maître de stage

HAROUNA OUEDRAOGO

Tel *76467679*

Stagiaire

KOALA Fernand

Tel : 67676991

Superviseurs

TABLE DES MATIERES

LISTES DES ABREVIATIONS

INTRODUCTION

I. Collectes des données

1. Généralités

1.1. Situation géographique

1.2. Historique

1.3. Dimension de la concession

1.4. Type d'habitat

1.5. Description physique des bâtiments

2. Habitants

3. Situation socioculturelles

3.1. Ethnie

3.2. Langue parlée

3.3. Religion

3.4. Coutumes mœurs-croyances

3.5. Organisation sociale

3.6. Loisir

3.7. Habitude alimentaires

3.8. Comportement à risque

4. Situation économique

5. Approvisionnement en eau

5.1. Source

5.2. Transport

5.3. Traitement

5.4. Conservation

6. Hygiène de l'habitat

- 6.1. Salubrité**
- 6.2. Description physique de la cour**
- 6.3. Cohabitation avec les animaux**
- 6.4. Situation**

7. Situation sanitaire

- 7.1. Etat de santé de la famille**
- 7.2. Accessibilité aux soins**
- 7.3. Comportements sanitaires de la famille**
- 7.4. Coutumes-mœurs-organes en rapport avec la santé**
- 7.5. Pratiques néfastes en rapport avec la santé**

II. Traitement des données

- 1. Analyse et interprétation des données**
- 2. Identification des problèmes**
- 3. Classification des problèmes par priorité**
- 4. Choix du problème à résoudre**
- 5. Analyse du problème à résoudre**

III. Plan d'action

- 1. Formulation des objectifs**
 - 1.1. Objectifs général**
 - 1.2. Objectif spécifique**
- 2. Choix des stratégies**
- 3. Détermination des activités**
- 4. Identifications des ressources**
- 5. Chronogrammes des activités**
- 6. Exécution des actions**
- 7. Suivi et évaluation**

Conclusion

LISTE DES ABREVIATIONS

- **AA : Accoucheuse auxiliaire**
- **AIS : Agent Itinérant des Santé**
- **ASBC : agent de santé à Base Communautaire**
- **CCC : Communication pour le Changement de Comportement**
- **COGES ; Comité de Gestion**
- **ICP : Infirmier Chef de Poste**
- **AMIU : Aspiration Manuelle Intra-Utérine**
- **CM : Centre Médical**
- **CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale**
- **DS : District Sanitaire**
- **ECD : Equipe Cadre du District -**
IB : Infirmier Breveté
- **IDE : Infirmier Diplômé d'Etat**
- **SFE/ME : Sage-Femme d'Etat / Maïeuticien d'Etat**
- **IEC : Information Education et Communication**
- **MEG : Médicament Essentiel Générique**
- **PF : Planification Familiale**
- **PV/VIH : Personne Vivante avec le VIH**
- **SIDA : Syndrome de l'Immuno Déficience Acquise**
- **TLOH : Télégramme Lettre Officielle Hebdomadaire**
- **VIH : Virus de l'Immuno déficience Humaine**
- **ASC : Agent de Santé Communautaire**
- **AV : Accoucheuse Villageoise**
- **PI : Prévention des infections**
- **SR ; Santé Reproductive**
- **CHR : Centre Hospitalier régional**
- **CMA : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale**
- **CPN : Consultation Prénatale**
- **OMS : Organisation Mondiale de la Santé**

- MILDA : Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action Introduction

La santé constitue l'une des préoccupations majeures de tout pays aspirant à un développement durable.

L'École Nationale de Santé Publique (ENSP) de Ouagadougou, en tant qu'institution de formation sanitaire, contribue activement à la mise en œuvre de la politique nationale de santé du Burkina Faso.

Dans le cadre de la formation des élèves infirmiers et maïeuticiens, l'ENSP organise un stage de synthèse en milieu rural d'une durée de quarante-cinq (45) jours, allant du 1er octobre au 14 novembre 2025. C'est dans cette optique que le Centre Médical (CM) de Niou, situé dans la commune de Boussé, a été choisi comme site de stage pour notre équipe composée de quatre (4) élèves infirmiers et de quatre (4) sages-femmes.

Le présent rapport porte sur l'étude de la famille OUEDRAOGO Issa, dont le but est de recenser les problèmes de santé existants et de proposer des solutions adaptées. Les principales techniques utilisées pour la collecte des informations ont été :

L'observation directe ;

La revue documentaire ;

Et l'entretien individuel.

Notre travail s'articule autour de trois grandes parties :

La collecte des données ;

Le traitement des données ;

L'élaboration d'un plan d'action

I. COLLECTE DES DONNEES

1. Généralités

1.1. Situation géographique

La famille OUEDRAOGO Issa réside à Niou/Yarssé, dans la commune de Boussé.

Géographiquement, leur cour se situe au nord-est du Centre Médical (CM) de Niou, à environ un (1) kilomètre de distance.

Elle est accessible par la Route Nationale n°2, bordée au sud par le marché de Niou, ce qui en facilite la localisation.

1.2. Historique

1.3. Monsieur OUEDRAOGO Issa est né à Niou. Ses parents sont originaires de Kaya, dans la région du Centre-Nord. Il y vit depuis sa naissance et y a établi sa propre famille.

Dimension de la concession

La concession est construite sur une superficie d'environ 300 m², de forme carrée et plane.

Elle comprend les habitations, une cour commune, des dépendances et des abris pour les animaux.

1.4. Type d'habitat

La concession comprend trois maisons et une cuisine construites en matériaux définitifs.

On y trouve également une douche et une latrine.

Un arbre à l'entrée procure de l'ombre aux membres de la famille.

La concession est clôturée en matériaux définitifs, mais sans porte à l'entrée

Description physique des bâtiments

Description physique des bâtiments

La maison principale du chef de famille se trouve à gauche de l'entrée et comprend une chambre et un salon.

À proximité, un hangar sert d'espace de repos.

Sur le côté droit, la maison de l'épouse est construite de façon similaire.

En face, se trouve la maison du fils aîné ; à l'arrière, un hangar abrite les bœufs, chèvres et l'âne.

2. Habitants

Monsieur OUEDRAOGO Issa est marié selon les coutumes de son milieu.

Il partage sa vie avec une seule épouse.

Le couple a quatre (4) enfants, dont deux garçons et deux filles.

Leur ménage est élargi, car la cour abrite également trois (3) petites-filles vivant avec eux, ainsi qu'un frère cadet du chef de famille.

Le tableau ci-dessous présente les membres de la famille :

N°	Statut/position	Sexe	Ages	Niveau de scolarisation	Professions
1	Chef de famille	M	55ans	Non scolarisé	cultivateur /éleveur
2	épouse	F	45ans	Non scolarisé	commerçante
3	Grand père	M	82 ans	Non scolarisé	Personne agé
4	1 ^{er} enfant	M	28ans	6ème	Cultivateur
5	2 ^e enfant	F	25 ans	5 eme	Femme au foyer
6	3 ^e enfant	M	23ans	3eme	Aventurier
7	5e enfant	F	20Ans	4e	Elève
8	6 ^e enfant	M	18 ans	Seconde	Élève
9	7e enfant	F	15 ans	5eme	Eleve
10	1eme petite fille	F	8ans	C1	Élève

3 . Situation socioculturelle

3.1Ethnie

La famille de Mr OUEDRAOGO est mossi

3.2 Les langues parlées

Les langues couramment parlées dans la famille sont le mooré (langue maternelle) et le français, utilisé principalement par les enfants scolarisés..

3.3 Religion

La famille est de religion musulmane et pratique régulièrement la prière et les traditions associées à l'islam.

3.4 Coutumes- mœurs –croyances

Monsieur OUEDRAOGO Issa est monogame.

La famille a pour totems la viande de porc, de chien et de serpent, qu'elle s'abstient de consommer selon les croyances familiales.

Le chef de famille détient l'autorité principale et prend les décisions importantes après consultation occasionnelle de son épouse.

La communication familiale est harmonieuse : les échanges se déroulent sans obstacle entre le mari, la femme et les enfants.

Monsieur OUEDRAOGO est le chef de famille et c'est lui qui a le pouvoir de décision. Il consulte ses épouses de temps en temps au sujet des questions importantes sur le plan social.

En termes de communication Monsieur Oudraogo et ses épouses n'ont aucun obstacle qui concerne leurs échanges ou le dialogue familial.

La femme de Mr Oudraogo quant à elle, obéit à son mari et les enfants suivent également les conseils de leurs parents. C'est les parents qui décident à leur place pour tous les problèmes leur concernant.

3.5 Loisirs

Après leurs activités quotidiennes, Monsieur OUEDRAOGO et son épouse se retrouvent souvent le soir pour des causeries en famille.

Ils apprécient les émissions radiophoniques, les contes traditionnels et les activités socioculturelles organisées dans le village.

L'épouse manifeste un intérêt particulier pour la musique traditionnelle.

Les enfants, quant à eux, s'adonnent à la pratique du football et à l'écoute de musiques enregistrées sur leurs téléphones.

Habitudes alimentaires

L'alimentation de base de la famille OUEDRAOGO est le tô de maïs ou de sorgho, accompagné de sauces à base de gombo (frais ou sec), de feuilles de baobab, d'oseille, ou de boulvaka, selon la saison.

Les sauces contiennent généralement du soubala, du poisson sec ou de la viande lorsque disponible.

Le menu hebdomadaire varie entre le tô, le riz, le gonré et le haricot, consommés de manière alternée.

3.6 Comportement à risque

La consommation d'alcool (dolo), de cigarette ou d'autres substances toxiques n'est pas pratiquée dans la famille.

Cependant, la consommation d'excitants tels que le thé et le café instantané (Nescafé) est courante.

Selon le chef de famille, certaines pratiques traditionnelles nuisibles à la santé telles que l'extraction du colostrum, l'excision et le pèrèl ont été abandonnées

3.7 situation économique

. Monsieur OUEDRAOGO Issa exerce la profession de cultivateur.

Son épouse pratique l'élevage de petits ruminants et effectue un petit commerce de produits locaux tels que l'arachide, le soubala et les noyaux de karité.

Pendant la saison pluvieuse, toute la famille participe aux travaux agricoles.

Estimation des ressources de la famille OUEDRAOGO par ans

	Sources	Quantité (sac de 60 Kg)	Valeur en FCFA
Agriculture	Maïs	4 sacs	120 000
	Mil	2 sacs	50 000
	Haricots	1 sac	50 000
	Arachide	4 sacs	85 000
	Sorgho	Néant	Néant
Elevage	Ane	01	Néant
	Chèvres	05	Néant
	volailles	10	Neant
Autres bien	Soutien enfants des		300 000
	Autre revenue		70 000
Total			675 000

• Tableau des dépenses annuelles de la famille Ouedraogo

Type des dépenses	Montants annuels en FCFA
Achat des condiments	75 000f
Santé	150 000
Evènement sociaux	100.000
Autres dépenses	50000
Total	660 000

II. Traitement des données 1. Analyse et interprétation des données

Au terme de la collecte des données, nous allons donner une valeur à ces données en faisant l'analyse et l'interprétation :

- La situation géographique de la concession facilite la fréquentation du CSPS permettant la prise en charge rapide des affections afin d'éviter les complications ;
- Les membres de la famille fréquentent le CSPS ce qui permet d'éviter les complications des maladies
- La cour est balayée chaque jour cela permet d'éviter la morsure des reptiles qui pourra nuire à la santé ;
- L'alimentation de la famille est variée et assez riche ce qui permet d'éviter la malnutrition ;
- Le reste du repas est couvert et chauffé ce qui empêche les mouches d'y pénétrer afin d'éviter les maladies diarrhéiques ;
- L'approvisionnement en eau se fait à partir d'un forage cela permet d'avoir de l'eau potable afin d'éviter les maladies hydriques ;
- L'existence de latrine permet d'éviter les défécations à l'air libre et la prolifération des germes entraînant les maladies parasitaires et diarrhéiques ;
- L'excision, le sororat, le mariage forcé et précoce ne sont pas pratiqués, ce qui pourrait réduire la prévalence des IST/VIH/SIDA et les accouchements dystociques.
- La famille ne dispose pas de fosse septique pour les eaux usées de douche, ce qui favorise la prolifération des moustiques et d'autres germes entraînant les maladies parasitaires et diarrhéiques.
- La famille utilise des MILDA des fois ce qui réduit un peu le paludisme
- Les ordures ménagères ainsi que les eaux usées sont déversées dans une fosse fumière à côté de la cour, cela favorise la prolifération des moustiques ou autres germes responsables des maladies parasitaires ou diarrhéiques ;
- Les membres de la famille mangent les fruits non lavés avec les mains sales, cela pourrait entraîner
- Des maladies diarrhéiques ;
- La famille utilise souvent des tisanes, cela pourrait entraîner une intoxication ;
- La famille dispose d'une épargne, ce qui lui permet d'honorer les ordonnances médicales en cas de maladies et de subvenir à d'autres besoins ;
- Les membres de la famille cohabitent avec les animaux cela pourrait entraîner les maladies zoonotiques.

A l'issue de cette analyse et interprétation des données, on peut faire ressortir des points positifs et des points négatifs à améliorer.

Points positifs	Points négatifs
- La proximité de la concession par rapport au CSPS; - La non pratique de l'excision, le sororat et les mariages forcés et précoces ; - L'approvisionnement en eau à partir de la nappe souterraine ; La - présence de latrines ; - La propriété de la cour - La fréquentation régulière du CSPS	- La pratique du lévirat - La consommation des tisanes ; - La cohabitation avec les animaux domiciles - Le manque d'hygiène des mains et des fruits ; - Le non-respect du système d'évacuation des eaux usées -La faible utilisation des MILDA

2. Identification des problèmes

L'analyse et l'interprétation des données, nous ont permis de retenir certains problèmes de santé de la famille OUEDRAOGO Issa qui se présentent comme suit :

A : absence de système d'évacuation des eaux usées ;

B: le manque d'hygiène des mains et des fruits ;

C : la cohabitation de la famille avec les animaux ;

D : la pratique du lévirat dans la famille ;

E : L'utilisation des tisanes par les membres de la famille.

F : La pratique du lévirat

3. Classification des problèmes

Les problèmes sont classés selon les critères suivants :

- L'ampleur ;
- La gravité ;
- La perception ;
- La vulnérabilité ; - L'acceptabilité

Problèmes	Ampleur	Gravité	Vulnérabilité	Perception	Acceptabilité	Score	Rang
A	++	++	+	+	+	07	5 ^e
B	++	+++	+	+	+	08	4 ^e
C	+++	+++	++	++	+	10	3 ^e
D	+++	+++	++	++	+	11	2 ^e

E	+++	+++	+++	++	++	13	1 ^{er}
---	-----	-----	-----	----	----	----	-----------------

Légende :

+ faible

++ moyen

+++ fort

4. Choix du problème prioritaire

Après la classification des problèmes par ordre de priorité, notre choix porte sur le problème qui a enregistré le score le plus élevé. Il s'agit du problème E : absence de système d'évacuation des eaux usées.

5. Analyse du problème prioritaire

Problème prioritaire	Causes	Conséquences	Solutions
Absence de système d'évacuation des eaux usées.	- Ignorance ; - Pauvreté - Insuffisance d'IEC - Manque de visite à domicile par les agents de santé	- Mortalités et morbidité - Maladies diarrhéiques - Prolifération des moustiques	- Sensibilisation sur le mode transmission des maladies - Utilisation des MILDA - Promouvoir la construction de fosse septique ; - Sensibilisation sur un bon système de drainage des eaux usées - VAD - Causerie débat

III. Plan d'action

1. Formulation des objectifs

1.1. Objectif général

Contribuer à améliorer l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie de la famille Ouedraogo d'ici 14 NOVEMBRE 2025.

1.2. Objectifs spécifiques

1. Amener les membres de la famille Ouedraogo à disposer d'une fosse septique pour récupérer les eaux de douches d'ici fin du mois de juin 2024.
2. Amener les membres de la famille Ouedraogo à connaître les dangers liés à la stagnation des eaux usées d'ici début Juillet 2024.

3 Choix des stratégies

- Information éducation- communication/ communication pour le changement de comportement (IEC/CCC)
- Visite a domicile ;
- Plaidoyer ;
- Causerie éducative.

4. Détermination des activités

Activité 1 : organiser trois séances de causerie éducatives sur les risques liés à la mauvaise évacuation des eaux usées ;

Activité 2 : Exécuter trois séances de réalisation des fosses septiques

Activité 3 : vérifier l'utilisation correcte de la fosse septique par deux membres de la famille.

Objectifs Spécifiques	Stratégies	Activités	Ressources		
			Humaines	Matériels	Financières
1	-IEC/CC - VAD	Activité 1 : organiser trois séances de causerie éducatives sur les risques liés à la mauvaise évacuation des eaux usées ;	- Stagiaires IDE - Membres de la famille - ASBC	- Chaises - Table - Tabouret - Bancs - Bics et cahier	4.identification des ressources
2	Plaidoyer	Activité 2 : Exécuter trois séances de réalisation des fosses septiques	- Stagiaires IDE - Membres de la famille - ASBC	Pelles Pioches Brouettes Houe et daba Cailloux sauvages Eau	
3		Activité 3 : vérifier l'utilisation correcte de la fosse septique par deux membres de la famille.	- Stagiaires IDE - Membres de la famille - ASBC	Bancs Bics et cahier Plat Eau usées chaises	

5Chronogramme des activités ou diagramme de GANT

Période d'exécution : 01 au 31 octobre 2025

Activités	01 au 10 octobre 2025							11 au 20 octobre 2025							21 au 31 octobre 2025						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ACTIVITE 1																					
ACTIVITE 2																					
ACTIVITE 3																					

6- EXECUTION

ACTIVITES	Dates d'exécution	Difficultés
Activité 1	- 01 octobre 2025 - 16 octobre 2025 - 18 octobre 2025	langue
Activité 2	- 28 octobre 2025 - 29 octobre 2025 - 30 octobre 2025	Langue

Activité 3	- 03 Novembre 2025 - 14 Novembre 2025	Néant
------------	--	-------

7- Suivi et évaluation

Activités prévues	Activités réalisées	Taux de réalisation
Trois causeries éducatives sur les risques liés à la mauvaise évacuation des eaux usées	03	100%
Trois séances de réalisation des fosses septiques	03	100%
Deux visites à domicile pour vérification	02	100%

Dans l'ensemble nos activités programmées ont été réalisées à 100% avec une bonne participation de la famille Ouedraogo

CONCLUSION

Le stage en milieu rural que nous avons effectué au Centre Médical (CM) de Niou nous a permis de réaliser une étude approfondie de la famille OUEDRAOGO Issa.

Cette étude a permis de recueillir des informations pertinentes sur la situation géographique, socioculturelle, économique et sanitaire de la famille, ainsi que d'identifier les problèmes de santé qui y existent.

À partir de ces données, un plan d'action approprié a été élaboré et exécuté, avec la participation active de la famille et l'appui du personnel de santé.

Grâce à cette expérience, nous avons pu renforcer nos compétences pratiques en matière de diagnostic communautaire, d'analyse de problèmes de santé, de planification et de mise en œuvre d'activités de sensibilisation.

Ce stage a été d'un grand apport pédagogique, car il nous a permis d'allier connaissances théoriques et expériences de terrain, tout en développant un esprit d'équipe et de responsabilité professionnelle.

Remerciements

Nous ne saurions terminer ce rapport sans exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes et structures qui ont contribué à la réussite de ce stage.

Nos remerciements s'adressent particulièrement à :

Tout le personnel du Centre Médical (CM) de Niou pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur accompagnement ; Monsieur HAROUNA OUEDRAOGO, notre maître de stage, pour sa supervision, ses conseils et son encadrement constant ;

L'Équipe de supervision de l'ENSP pour le suivi et l'évaluation de notre travail sur le terrain ;

Nos camarades stagiaires pour leur esprit de collaboration et de solidarité ;

Et enfin, à la famille OUEDRAOGO Issa, pour leur disponibilité, leur confiance et leur collaboration durant toute la période de notre étude.